

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

SADS · SOCIAL AVOIDANCE AND DISTRESS SCALE

Escala de Ansiedad y Evitación Social de Watson y Friend – Instrumento de evaluación de fobia social, timidez invalidante y malestar interpersonal

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Social Avoidance and Distress Scale (SADS)
Nombre en español	Escala de Estrés y Evitación Social (Watson y Friend)
Sigla oficial	SADS
Autores originales	David Watson y Ronald Friend (1969)
Adaptación hispanohablante	Julio Bobes, Xavier Badía, A. Luque, M. P. García-Portilla, M. P. González y M. T. Bascarán (2002)
Año de publicación original	1969 (validación española de referencia en 2002)
Constructo primario	Malestar emocional/ansiedad subjetiva en contextos sociales y conductas de evitación o escape
Formato de administración	Autoinforme estructurado con formato dicotómico Verdadero / Falso (V/F)
Población diana	Población clínica y universitaria adolescente y adulta (≥ 16 años) con fobia social
Tiempo de aplicación	8 a 12 minutos (28 ítems)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de acceso académico libre respetando citación de autoría

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Social Avoidance and Distress Scale** (SADS) fue construida por David Watson y Ronald Friend (1969) junto a la **Fear of Negative Evaluation Scale** (FNE) como uno de los pilares fundacionales de la investigación psicométrica sobre la ansiedad social y evaluativa. El marco conceptual distingue con claridad entre el componente cognitivo de temor a la desaprobación ajena (evaluado por la FNE) y las manifestaciones afectivas y conductuales de la fobia social, evaluadas por la SADS.

La escala operacionaliza dos factores estrechamente interconectados: 1) la experiencia subjetiva de malestar emocional, tensión psicológica y angustia en situaciones interpersonales (**Social Distress**); y 2) el deseo deliberado, la tendencia al aislamiento y la ejecución efectiva de conductas de evitación o huida de grupos, desconocidos o figuras de autoridad (**Social Avoidance**). La adaptación española liderada por Bobes et al. (2002) confirmó su robustez psicométrica en el Sistema Nacional de Salud, acreditando su validez como herramienta de evaluación síndromica, medición de severidad basal y monitorización de la eficacia terapéutica en ensayos de fármacos ansiolíticos y terapia cognitivo-conductual.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión / Factor	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Malestar / Ansiedad Social (Distress)	14 ítems	0 – 14	Experiencia de nerviosismo, tensión, disgusto y falta de calma en situaciones sociales y ante desconocidos (ej. ítems 5, 10, 11, 14, 16, 20, 23).
2. Evitación Social (Avoidance)	14 ítems	0 – 14	Conductas de distanciamiento, excusas para no acudir a actos, aislamiento voluntario y huida de multitudes (ej. ítems 2, 8, 13, 18, 21, 24, 26).
Puntuación Total SADS	28 ítems	0 – 28	Suma dicotómica directa de los 28 ítems según clave de corrección con ítems directos e invertidos.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna total	Alpha de Cronbach = 0.91 – 0.94	Excelente fiabilidad en la validación española de Bobes et al. (2002) en pacientes con fobia social y controles.
Consistencia de subescalas	Alpha = 0.85 – 0.88	Elevada homogeneidad en ambas subescalas: Malestar social (0.88) y Evitación conductual (0.85).
Fiabilidad test-retest	r = 0.84 – 0.90 (2 semanas)	Gran estabilidad temporal en pacientes antes de recibir tratamiento psicofarmacológico o psicológico.
Validez concurrente	r = 0.77 con SIAS; r = 0.74 con LSAS	Fuerte correlación convergente con la Escala de Ansiedad de Interacción Social y la escala de Liebowitz.
Sensibilidad al cambio	Effect size d = 1.15	Marcada reducción de la puntuación tras tratamiento con ISRS y terapia cognitivo-conductual de exposición.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Formato de respuesta:** Cada uno de los 28 ítems se contesta como **Verdadero (V)** o **Falso (F)**.
- **Clave de Corrección (Direccionalidad de Ítems):**
 - **Puntúan 1 con respuesta VERDADERO (14 ítems):** Ítems 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24 y 26.
 - **Puntúan 1 con respuesta FALSO (14 ítems invertidos):** Ítems 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 25, 27 y 28 (evalúan seguridad o confort social).
- **Puntuación Total:** Suma de las respuestas afirmativas a la clave patológica (rango: 0 a 28 puntos).
- **Subescalas opcionales:** Puede computarse la suma parcial de los 14 ítems de Malestar Social (0-14) y de los 14 de Evitación Social (0-14).
- **Criterio de validez formal:** Si se omiten más de 2 ítems, el protocolo se considera no concluyente.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Estratificación Clínica	Significación Psicopatológica y Repercusión Funcional
0 – 6 puntos	Ansiedad Social Normal / Baja	Comportamiento social adaptativo. Confort interpersonal habitual sin interferencia laboral ni afectiva.
7 – 10 puntos	Timidez Moderada / Subclínica	Incomodidad leve en situaciones novedosas o ante figuras de autoridad. No cumple criterios de fobia social.
11 – 15 puntos	Fobia Social Leve a Moderada	Umbral clínico inicial. Ansiedad social clínicamente significativa con evitación de reuniones masivas o situaciones sociales formales.
16 – 28 puntos	Fobia Social Grave / Generalizada	Gravedad clínica severa. Fuerte aislamiento interpersonal, evitación sistemática, marcada interferencia laboral, académica y vincular.

PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA (BOBES ET AL., 2002): Una puntuación **≥ 11 puntos** optimiza la sensibilidad en cribado, mientras que un puntaje **≥ 16 puntos** ofrece una especificidad diagnóstica superior al 85% para Trastorno de Ansiedad Social generalizada según criterios DSM/CIE.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Identificación y administración de cribado:

- Aplicar la SADS en pacientes que refieren aislamiento, consumo de alcohol como desinhibidor en fiestas, o dificultades en el rendimiento académico/laboral con grupos.

Paso 2: Análisis del perfil diferencial entre Malestar y Evitación:

- **Malestar Alto (> 8) con Evitación Baja (< 5):** El paciente sufre notablemente pero se expone (ansiedad de ejecución o fobia social no generalizada). Foco en desensibilización fisiológica y reestructuración cognitiva.
- **Malestar Alto (> 8) y Evitación Alta (> 8):** Fobia social generalizada consolidada. Patrón de repliegue crónico.

Paso 3: Vía de tratamiento asistencial recomendada:

- **SADS 11 – 15:** Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) grupal o individual: reestructuración de pensamientos automáticos de incompetencia, entrenamiento en habilidades sociales y exposición gradual.
- **SADS ≥ 16:** Tratamiento combinado: TCC estructurada de exposición + farmacoterapia de primera línea (ISRS como Sertralina, Escitalopram o Paroxetina / Venlafaxina) para reducir el tono autonómico y posibilitar la exposición conductual.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Mujer de 24 años, estudiante de último año de Derecho, acude a consulta psicológica universitaria por bloqueo extremo, náuseas y crisis de ansiedad cada vez que debe intervenir en seminarios o asistir a recepciones de prácticas profesionales.

Resultados en la SADS:

- Puntuación Total: **21 puntos / 28** (Fobia Social Grave / Generalizada).
- Malestar Social (Distress): 12 / 14 (tensión intensa, sensación de ahogo ante extraños, taquicardia al hablar con profesores).
- Evitación Social (Avoidance): 9 / 14 (inventa excusas para no acudir a reuniones, no asiste a celebraciones, evita saludar a compañeros en los pasillos).
- Escalas complementarias: BDI-II = 14 (depresión leve secundaria al aislamiento); LSAS = 82 (ansiedad social grave).

Intervención y Seguimiento: Se diagnosticó Trastorno de Ansiedad Social (Fobia Social Generalizada). Se instauró tratamiento con Escitalopram 10 mg/día junto a un protocolo de TCC de 14 sesiones basado en experimentos conductuales de exposición con desensibilización sistemática del foco atencional (modelo de Clark y Wells). A los 4 meses, la puntuación total en la SADS descendió a 9 puntos (rango de timidez no patológica), logrando defender su trabajo fin de grado con éxito.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS CLÍNICAS Y RIESGOS:

- **Automediación etílica:** El abuso de alcohol y sedantes es la comorbilidad más prevalente en pacientes con SADS ≥ 16 como mecanismo para tolerar eventos sociales.
- **Depresión mayor secundaria:** El aislamiento prolongado derivado de la evitación social es una vía frecuente hacia cuadros distímicos y tentativas autolíticas.
- **Deserción académica y laboral:** Monitorear el absentismo generado por la incapacidad de someterse a evaluaciones presenciales.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Trastorno de la Personalidad Evitativa:** En la personalidad evitativa, los patrones son egosintónicos y afectan a toda la biografía desde la infancia; en la fobia social, hay clara egodistonía.
- **Agorafobia:** La agorafobia teme la imposibilidad de recibir ayuda ante un ataque de pánico; la fobia social teme el escrutinio, el ridículo y la desaprobación.
- **Espectro autista / Asperger:** En el TEA el déficit radica en la reciprocidad y lectura mental social; en la SADS la lectura social es adecuada pero hiperalerta.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurement of social-evaluative anxiety. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 33(4), 448–457. <https://doi.org/10.1037/h0027806>
2. Bobes, J., Badía, X., Luque, A., García-Portilla, M. P., González, M. P., & Bascarán, M. T. (2002). Validación de las versiones en español de las escalas de fobia social SIAS y SADS. *Medicina Clínica*, 118(12), 445–449. [https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(02\)72418-8](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(02)72418-8)
3. Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
4. Clark, D. M., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R. G. Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A. Hope, & F. R. Schneier (Eds.), *Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment* (pp. 69–93). Guilford Press.